

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO OVIEDO DE CALIDAD DEL SUEÑO (COS)

Eje VI: Somática, Sueño y Salud Mental • Evaluación Clínica Específica de Julio Bobes y Grupo de Oviedo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario Oviedo de Sueño (COS; versión clínica estructurada).
Nombre Original	Cuestionario Oviedo de Sueño (COS; Bobes et al., 1998, 2000; Universidad de Oviedo).
Autores Originales	Julio Bobes, M. Paz González, Pilar A. Sáiz, M. Teresa Bascarán, Celso Iglesias y J. M. Fernández.
Ámbito Geográfico	Desarrollado y baremado en España; adoptado ampliamente en salud mental ambulatoria.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Sueño. Calidad subjetiva del sueño, insomnio e hipersomnia en psiquiatría.
Tipo de Instrumento	Entrevista semiestructurada heteroaplicada (o autoinforme supervisado en consulta).
Composición de Ítems	15 reactivos clínicos organizados en 3 subescalas independientes y preguntas de hipnóticos.
Población y Rango	Adultos y ancianos (≥ 18 años); validado específicamente en trastornos depresivos y de ansiedad.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos de cumplimentación y valoración de las últimas 4 semanas de sueño.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico asistencial e investigación médica sin coste.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL SUEÑO EN LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

El **Cuestionario Oviedo de Sueño (COS)** fue concebido por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo para superar las limitaciones de las escalas genéricas de sueño:

- Diseño Específico para Población Clínica:** La mayoría de cuestionarios de sueño provienen de la medicina somática del sueño; el COS se ajustó específicamente a los perfiles de insomnio de conciliación, fragmentación nocturna y despertar precoz propios de los trastornos depresivos.
- Tres Dimensiones Independientes:** Proporciona puntuaciones separadas para Satisfacción Subjetiva (1 ítem), Insomnio (9 ítems) e Hipersomnia (3 ítems), permitiendo identificar si el paciente presenta hipersomnia atípica o insomnio severo.
- Monitorización de Hipnóticos:** Registra explícitamente el uso cuantitativo de fármacos sedantes y la presencia de parasomnias (pesadillas, sacudidas musculares).

3. LAS 3 SUBESCALAS CLÍNICAS DEL COS

Subescala Clínica COS	Rango Pts	Reactivos y Procesos Clínicos Evaluados
1. Satisfacción Subjetiva	1 a 7 puntos	Ítem 1: Valoración global de la calidad del sueño (desde 1 = Muy insatisfecho a 7 = Muy satisfecho).
2. Subescala de Insomnio	9 a 45 puntos	Ítems 2 (1-5), 3, 4, 5 y 6: Latencia de sueño, despertares nocturnos, horas dormidas, cansancio matutino.
3. Subescala de Hipersomnia	3 a 15 puntos	Ítems 7, 8 y 9: Somnolencia diurna excesiva, duración y necesidad irrefrenable de siestas.
Preguntas Adicionales	Informativo	Uso y frecuencia de benzodiacepinas/fármacos hipnóticos y presencia de pesadillas.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Los estudios de validación del Grupo de Oviedo (Bobes et al., 2000; García-Portilla et al., 2009; $N > 700$) avalan su rigor:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia (Insomnio)	Alfa de Cronbach = 0.88 - 0.90	Excelente homogeneidad métrica en los ítems de alteración del sueño.
Consistencia (Hipersomnia)	Alfa = 0.82 - 0.85	Buena fiabilidad interna en los reactivos de somnolencia diurna.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.86 (a 1 semana)	Gran reproducibilidad temporal en pacientes psiquiátricos estables.
Sensibilidad en Depresión	Sensibilidad = 88%	Detección exhaustiva de la fragmentación del sueño en el episodio depresivo.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 85%	Distingue con precisión controles sanos de insomnio clínicamente relevante.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **No se Suma un Total Global:** El COS está diseñado para interpretarse a través de sus tres subescalas independientes:
- **Satisfacción Subjetiva:** Rango 1 a 7 puntos (a mayor valor, mayor satisfacción).
- **Puntuación de Insomnio:** Sumatoria de los 9 ítems de insomnio (rango 9 a 45 puntos).

$$\text{Subescala de Insomnio} = \text{Ítems } (2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 3 + 4 + 5 + 6) \quad (9 \text{ a } 45 \text{ puntos})$$

- **Puntuación de Hipersomnia:** Sumatoria de los 3 ítems de hipersomnia (rango 3 a 15 puntos).

$$\text{Subescala de Hipersomnia} = \text{Ítems } (7 + 8 + 9) \quad (3 \text{ a } 15 \text{ puntos})$$

- **Direccionalidad:** En Insomnio e Hipersomnia, mayores puntuaciones indican mayor gravedad de la patología del sueño.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Insomnio (9-45)	Satisfacción (1-7)	Significación Clínica y Nivel de Compromiso (Bobes et al.)
Sueño Normal	9 a 22 puntos	5 a 7 (Satisfecho)	Patrón de sueño fisiológico; descanso nocturno reparador.
Insomnio Leve	23 a 28 puntos	4 (Neutro)	Dificultades de conciliación o despertares tolerables; pautas de higiene.
Insomnio Clínico	29 a 37 puntos	2 a 3 (Insatisfecho)	Punto de corte canónico (≥ 29 pts) insomnio clínicamente significativo.
Insomnio Grave	38 a 45 puntos	1 (Muy insatisfecho)	Compromiso severo e incapacitante colapso diurno; tratamiento urgente.

PUNTO DE CORTE DE INSOMNIO CLÍNICO CANÓNICO (COS INSOMNIO ≥ 29 PUNTOS):

Una puntuación en la **Subescala de Insomnio ≥ 29 puntos** (asociada a una Satisfacción Subjetiva ≤ 3) define de forma indiscutible un insomnio clínicamente significativo que requiere intervención activa (terapia cognitivo-conductual para insomnio - TCC-I y/o ajuste de farmacoterapia sedante nocturna).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN TRASTORNOS DEL SUEÑO PSIQUIÁTRICOS

PROTOCOLO DE MANEJO CLINIMÉTRICO CON EL CUESTIONARIO COS:

- **Paso 1 (Administración en Pacientes con Quejas Afectivas o de Sueño):** Aplicar las 3 subescalas explorando las últimas 4 semanas.
- **Paso 2 (Diagnóstico Fenotípico del Patrón de Sueño):**
 - **Insomnio ≥ 29 con Despertar Precoz (Ítem 2d):** Patrón melancólico clásico de la Depresión Mayor; asociar antidepressivo con perfil hipnótico nocturno (Mirtazapina o Trazodona).
 - **Insomnio de Conciliación Puro (Ítem 2a ≥ 4):** Típico de ansiedad generalizada o hiperactivación cognitiva; pautar TCC-I (control de estímulos y restricción del tiempo en cama).
 - **Hipersomnia Elevada (≥ 9 puntos) con Insomnio bajo:** Descartar depresión atípica, apnea obstructiva del sueño (STOP-Bang) o narcolepsia.
- **Paso 3 (Deshabitación de Hipnóticos):** Si el paciente consume benzodiacepinas a diario, planificar su sustitución gradual para evitar el insomnio de rebote crónico.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INSOMNIO DE DESPERTAR PRECOZ EN DEPRESIÓN

Identificación: Mujer de 51 años, administrativa, que acude a consulta de psiquiatría remitida por quejas de agotamiento crónico, pérdida de peso y llanto matutino, relatando que “se despierta a las 4 de la madrugada con una angustia terrible y ya no puede volver a dormir”.

Evaluación con el Cuestionario Oviedo de Sueño (COS):

- **Satisfacción Subjetiva (Ítem 1): 1 punto** (Muy insatisfecha).
- **Subescala de Insomnio: 35 / 45 puntos (Insomnio Clínico Severo,** muy superior al corte de 29).
- **Desglose de Ítems de Insomnio:** Tardanza en conciliar = 2 puntos; Despertares = 3; Despertar prematuro final = **5 puntos** (se despierta 3 horas antes de lo deseado); Horas dormidas = 4 puntos (duerme menos de 4 horas); Eficiencia = 4; Cansancio diurno = 5.
- **Subescala de Hipersomnia:** 4 / 15 puntos (ausencia de hipersomnia diurna).

Juicio Diagnóstico: Insomnio grave terminal característico de un Episodio Depresivo Mayor con síntomas melancólicos.

Plan Terapéutico: Se instauró Mirtazapina 15 mg por la noche (titulada a 30 mg) por su doble acción antidepressiva y antagonista H1/5-HT2A inductora del sueño profundo, junto con pautas de higiene circadiana. A las 3 semanas, la subescala de insomnio descendió a **16 puntos** y la satisfacción subjetiva ascendió a 6 (Satisfecha).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

TOLERANCIA A BENZODIACEPINAS:

El uso de BZD por más de 4 semanas cronifica el insomnio al alterar la arquitectura del sueño REM y delta; no mantener hipnóticos de forma indefinida.

DESPISTAJE DE APNEA (SAHOS):

Si la subescala de Hipersomnia es ≥ 9 con ronquidos audibles, descartar apnea del sueño antes de administrar sedantes que puedan deprimir la ventilación.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Bobes, J., González, M. P., Sáiz, P. A., Bascarán, M. T., Iglesias, C., & Fernández, J. M. (2000). Propiedades psicométricas del Cuestionario Oviedo de Sueño. *Psicothema*, 12(1), 107-112.
2. Bobes, J., et al. (1998). Evaluación de la calidad de vida en pacientes con insomnio. *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*, 25(Supl 1), 18-24.
3. García-Portilla, M. P., et al. (2009). The Oviedo Sleep Questionnaire: A new tool for the assessment of sleep disorders. *The European Journal of Psychiatry*, 23(1), 38-46.
4. Morin, C. M., & Benca, R. (2012). Chronic insomnia. *The Lancet*, 379(9821), 1129-1141.